

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	白內障 Cataract				
編號	A31000-Q03-W-I01	制定者	N09 陳美如	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 3.9 版/10 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解白內障的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與護理措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

白內障是眼科最常見的疾病之一，表示眼球中的水晶體變為混濁，光線無法完全透過造成視覺模糊所致。而水晶體位於眼球裡面，瞳孔之後，正常情況它是透明晶亮的，具有調節光線的功能。簡單地說，白內障就是原來透明的水晶體有混濁的現象。

（二）症狀

白內障早期的症狀可能有視力模糊、兩眼對於顏色的敏感度有落差產生色調改變、怕光、眼前黑點、複視、晶體性近視等，通常雙側都會發生，只是混濁程度不一定相同，調整眼鏡的度數無法改善視力、在陽光強的地方會越看不清楚、近視度數急遽增加、有時甚至會出現單眼複視情形。晚期症狀則為視力障礙日深，最後只能在眼前辨別手指或僅剩下光覺視力。白內障是一種老年退化疾病，隨著年紀增加會越嚴重，除了年紀之外，一些流行病學和實驗數據發現，暴露於一些有毒或較敏感的物质，會引起光氧化反應，造成水晶體的變化。

主題名稱	白內障	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-I01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/10

造成白內障的可能因素及危險因子如下說明：

1. 老年性白內障：為最常見的一種白內障，隨著年齡的增加，四、五十歲後，水晶體會慢慢發生硬化、混濁而漸造成視力的障礙。
2. 外傷性白內障：車禍、眼睛受到撞擊或遭受到鈍器傷害、尖銳物品的刺傷或穿透性眼內藥物所引起。
3. 併發性白內障：因反覆虹彩炎、眼內炎、壞死性鞏膜炎、青光眼、網膜色素病變等引起的白內障。
4. 代謝性白內障：如糖尿病、甲狀腺疾病等引起之白內障。
5. 藥物性白內障：因身體疾病而長期使用類固醇等藥物（如：自體免疫疾病）所引起之白內障。
6. 先天性白內障：由於遺傳性、染色體變異、胎內感染等所引起，嬰兒瞳孔內可見白色或灰色的混濁點，視力發展差。
7. 輻射性白內障：飛行員長期暴露在輻射較高的環境。
8. 其他：曾接受眼內手術（如：視網膜手術）、抽菸、喝酒、低社經地位亦為造成白內障可能原因。

（三）常見檢查

一般檢查，如：視力檢查、色盲表檢查病人辨色力及人工水晶體度數之計算。藉由矯正視力和裂隙燈檢查就能診斷白內障，經由瞳孔放大後，水晶體混濁的位置能夠更容易區別，另外完整的視網膜及視神經的檢查，排除病人視力減退是否有合併眼睛其他的問題。

（四）常見治療

1. 藥物治療：市面上的眼藥水——其作用只是減緩水晶體的代謝廢物之沉積，實際治療效果並不明顯。
2. 手術療法：白內障手術各有其優缺點，醫師依病情選擇最適當的手術。方法如下：
 - (1) 囊內白內障摘除術(intracapsular cataract extraction)。
 - (2) 囊外晶體摘除術合併後房人工水晶體植入。

主題名稱	白內障	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-I01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/10

(3) 超音波晶體乳化術合併後房人工水晶體植入。

(4) 晶體摘除術合併後房人工水晶體植入。

手術治療為白內障唯一直接有效的治療方法。手術時間約一小時或更短，手術的過程是將混濁的水晶體摘除，並置入人工水晶體，再縫合傷口，大多使用局部麻醉，有時可能給予鎮靜劑幫助放鬆。人工水晶體的選擇有分下列種類：

- A. 單焦點球面水晶體：傳統的人工水晶體設計。
- B. 單焦點非球面水晶體：非球面人工晶體與眼睛的結構雷同，比傳統的水晶體有更清晰的視覺，特別是在較暗的環境下和瞳孔較大的人更能凸顯其優點。單焦點非球面水晶體除了透明鏡片以外，另一種鏡片上渡有黃色的顏色，具有過濾藍光及紫外線的功能，但藉由水晶體還是無法達到百分百保護功能，所以出門還是要防曬及平時的視力保健，黃片水晶體只是多一層保護。
- C. 散光非球面水晶體：角膜散光度數越高，使用散光的人工水晶體能讓影像更清楚，效果也越好，但角膜散光有分為規則性及不規則性散光，若經評估是非規則性，則手術後效果也會不如預期，所以手術前散光分析是很重要的。
- D. 多焦點式水晶體：常使用近距離的工作或是手術後不想戴眼鏡，則必須考慮多焦點水晶體，不同的老花度數可供選擇。隨著水晶體不斷的進展，有三焦段或是長焦段的人工水晶體，三焦段水晶體是能提供好的中距離視覺，而不會影響到遠近距離視力。
- E. 多焦點散光水晶體：同時具有多焦點及矯正散光功能的水晶體，當然功能性較多，價格部份也較高。

(五) 護理問題

1. 知覺感受變異／與水晶體混濁有關
2. 尋求（特定的）健康協助／預防白內障惡化的注意事項

主題名稱	白內障	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-I01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/10

3. 易受傷害／術後合併症

(六) 護理措施

1. 知覺感受變異／與水晶體混濁有關

- (1) 瞭解病人視力改變的程度及感受。
- (2) 評估病人應付視力改變的能力。
- (3) 評估病人其它聽、嗅、觸覺的功能。
- (4) 告知病人環境的安排，將物品位置固定並一一介紹。
- (5) 指導病人使用視覺輔助器，如：放大鏡或焦距燈增加視力。
- (6) 將病人常用物品置於病人身邊，使病人容易取用。
- (7) 提供額外的照明但避免刺眼強光直射病人眼睛。
- (8) 若病人需閱讀書報雜誌，提供字體大且以藍色、綠色作為背景。
- (9) 進入病人病房前應敲門並通報姓名，使病人有安全感。
- (10) 做任何治療及護理前應先解釋，使病人有控制環境的感覺。
- (11) 與病人談話時應站在光照的位置使病人清楚直視對方。
- (12) 提供食物時可將食物位置、種類做介紹，方便病人選擇及進食。
- (13) 注意環境安全並移開走道雜物。
- (14) 盡量勿單獨留下病人，家屬離開時應告知護理人員。
- (15) 指導病人勿單獨行動，避免危險。

2. 尋求（特地的）健康協助／預防白內障惡化的注意事項

- (1) 避免吸菸，減少接觸尼古丁的物質。
- (2) 避免長期服用類固醇。
- (3) 糖尿病患者必須控制血糖在正常值範圍內，避免血糖值忽高忽低。
- (4) 外出時配戴適當顏色的太陽眼鏡，可使眼睛感覺舒適及減少紫外線之刺激。
- (5) 多攝取高蛋白食物、維生素 B 群和胡蘿蔔素。

主題名稱	白內障	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-I01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/10

3. 易受傷害／術後合併症

- (1) 手術後躺向健側，避免壓迫手術眼。
- (2) 飲食以清淡、少量多餐為宜，避免堅硬食物，防過度咀嚼，影響手術傷口癒合。
- (3) 保持眼部清潔無菌，手不可觸摸敷料及揉眼睛。
- (4) 避免強光照射，白天外出可配戴護目鏡或太陽眼鏡保護，增加眼睛舒適度。

(七) 衛教指導

1. 白內障手術後須知

- (1) 手術後開始服用口服藥吃完三天份即可。
- (2) 白內障是屬於眼內手術，手術完一個月內，在傷口癒合前禁止接觸到水，避免傷口感染。
- (3) 感染的症狀可能在術後 1~2 周內發生，若發現視力有減退，眼睛紅腫及疼痛，分泌物增加，即需立即回門診檢查。
- (4) 按時間點藥和依醫囑回門診追蹤。
- (5) 手術後不管傷口是否有縫線，眼睛異物感會持續 1-2 周，有時候會持續長時間，因人而異。
- (6) 若放置多焦點的人工水晶體，術後需要適應的時間會比單焦點長，因人而異。
- (7) 術前服用的藥物，如糖尿病、高血壓藥物，術後應照常服用。
- (8) 術後當天不必點眼藥水及藥膏，保持傷口乾燥且不要拆除，於術後第二天眼科門診複診，由醫師教導點眼藥方法。
- (9) 切勿揉眼睛，白天請戴太陽眼鏡，睡覺請戴鐵蓋鐵蓋(眼罩)且勿壓迫患眼。
- (10) 術後若患眼遭受外傷或撞擊，導致視力急速減退且劇烈疼痛時，請立即回院檢查。
- (11) 點眼藥時，需先將雙手洗淨且保持眼睛乾燥。
- (12) 點眼藥時請病人頭往上仰，將下眼瞼拉下點藥，勿壓上眼瞼。
- (13) 鐵蓋(眼罩)至少覆蓋一星期，白天可以眼鏡代替鐵蓋(眼罩)，但睡覺

主題名稱	白內障	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-I01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/10

時一定覆蓋，特別注意勿碰撞眼睛。

(14) 食物禁忌：煙、酒及辛辣，請攝取均衡的營養。

(15) 術後二週內儘量避免提過重的東西，也應該避免過度的低頭、用力咳嗽、曬太陽及吹風。

(16) 一般手術後看遠物時，不需戴眼鏡，看近物時戴一般老花眼鏡，並於手術後兩個月配戴眼鏡。

(17) 勿執行彎腰過大動作，如彎腰洗頭、綁鞋帶等，減少眼壓升高。

2.發燒的處理

(1) 發燒處理的常規

A. 36.0~37°C：正常。

B. 37.0~38°C：微燒，冰枕使用。

C. 38.0~39°C：中等燒，冰枕使用及溫水擦拭浴。

D. 39°C 以上：高燒，冰枕使用及溫水拭浴並於醫師指示下給予退燒藥。

(2) 發燒的護理

A. 冷敷法

(A)冰枕：

a. 冰枕內裝三分之二冰塊，加少許冷水。

b. 夾緊袋夾放入塑膠袋內，以乾毛巾包裹於枕後。

c. 檢測冰袋內冰塊隨時更換，約 2-3 小時更換一次。

B. 環境及衣物的調節

(A)合宜的室溫 22-27°C、溼度 60%。

(B)必要時打開窗戶，促進空氣流通。

(C)保持安靜，避免噪音。

(D)寒顫發抖時，可先加被蓋保暖。

(E)寒顫停止高燒持續時，應慢慢移除被蓋。

(F)當衣物出汗潮濕時，隨時更換。

主題名稱	白內障	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-I01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	7/10

C. 水份的補充

- (A) 多喝水---每日約 3000cc。
- (B) 經由點滴補充水份及電解質。

D. 保持清潔舒適

- (A) 口腔護理---清潔口腔如：漱口。
- (B) 當口唇乾裂時可擦甘油或脣膏。
- (C) 保持皮膚清潔及乾燥---勤換衣物。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 江宜靜、王守玉 (2020)・白內障完整評估治療與照護趨勢・護理雜誌，67(2)，84-90。https://doi.org/10.6224/JN.202004_67(2).11
- (二) 楊娟、李牧玲、黃清輝、李春梅、黃東梅、周宏珍 (2023)・眼科成人日間手術患者病區護理管理的最佳證據總結・眼科學報，38(8)，571-579。
doi:10.12419/2304250001
- (三) 李惠玲 (2024)・眼睛與耳朵疾病之護理・於劉雪娥總校閱，成人內外科護理 (第 9 版，下冊，第 15 章)・台北：華杏。
- (四) **American Academy of Ophthalmology. (2024, October). Cataract Surgery.**
Retrieved from https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-cataract-surgery

主題名稱	白內障	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-I01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	8/10

- (五) American Academy of Ophthalmology. (2024). *Cataract surgery*. Retrieved from <https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-cataract-surgery>
- (六) Ben-Eli, H., Cnaany, Y., Halpert, M., Chowers, I., & Goldstein, A. (2025). Investigating the impact of age and sex on cataract surgery complications and outcomes. *Scientific Reports*, 15, 1242. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-84382-4>
link.springer.com+9nature.com+9pubmed.ncbi.nlm.nih.gov+9
- (七) Ma, L., Hao, Z. X., Liu, R. R., Yu, R. B., Shi, Q., & Pan, J. P. (2023). A dose-response meta-analysis of dietary lutein and zeaxanthin intake in relation to the risk of age-related cataract. *Graefes Archives of Clinical and Experimental Ophthalmology*, 252(1), 63–70.

七、附件

(略)

主題名稱	白內障	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-I01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	9/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定	97 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	更正 APA 格式	100 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	增修內容及參考資料	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31.	3.1	增修第六項參考文獻資料	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.2	新增參考文獻於內文	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.3	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第一目；第二目之 7；四目之 2(4)；第六目之 1(15)、之 2(5)、之 3(3)參考資料修訂。 3. 第三項第六目之 3、第七目之 1(12)新增說明內容。 4. 第六項第五、七目新增。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.4	1. 第三項第二、三、四、七目新增內容及參考文獻。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年

主題名稱	白內障	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-I01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	10/10

修正日期	版本	修正說明	備註
		2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 3. 第六項新增參考資料。	09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	3.5	1. 第三項第二目之 6、第四目之 4、第六目之 3(3)新增內容及參考文獻。 2. 第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	3.6	1. 第三項第五、六目之護理問題：知覺改變修改為知覺感受變異。 2. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	3.7	1. 第三項第五目、第六目護理問題：知識缺失修改為尋求（特定的）健康協助；潛在危險性傷害修改為易受傷害。 2. 刪除年限較久之第六項參考資料。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過； 112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.09.03	3.8	1. 第三項第四目之 1.說明內容文辭修正。 2. 刪除第六項參考資料年限較久參考文獻。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過； 113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.10.08	3.9	修訂第六項參考文獻資料。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。